SDD 351 Sujet n°1

Spécialité : Médecine légale

Date : 24/02/2025
Auteur : Julie GAUTHIER (D.E.S. Médecine légale et expertises médicales)
Relecteur(s) : Laurène DUFAYET (MCU), Marie EPAIN (AHU), Audrey FARRUGIA (MCU), VILLARD Sébastien (interne DES médecine interne)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	/
Item(s) en lien avec la station	14 - Violences et santé 57 - Maltraitance et enfants en danger. Protection maternelle et infantile 66 - Diagnostiquer : un trouble dépressif, un trouble anxieux, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble de stress post-traumatique, un trouble de l'adaptation, un trouble de la personnalité 353 - Risque et conduite suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte : identification et prise en charge
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 351 - Violences physiques et psychologiques
Matériel nécessaire à la station	- Une table - Deux chaises - IPAD pour examinateur - Feuille de brouillon pour candidat - Stylo pour candidat - Feuille de brouillon pour évaluateur - Stylo pour évaluateur
Contexte de la station	Dépistage de violences pendant une consultation au cabinet

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne en médecine générale en cabinet.
Vous recevez au cabinet Mathis, 15 ans, amené par ses parents. Il se plaint de douleurs abdominales diffuses, de fièvre et de nausées. Il n'a aucun antécédent. Ses constantes sont dans la norme dont 36,8° de température.
Vous êtes seul.e avec lui pour l'examen. Il refuse de retirer son pull. Vous le trouvez prostré et il évite votre regard. Il accepte cependant une palpation abdominale à travers le pull, qui ne retrouve ni défense ni contracture. Vous suspectez que Mathis est victime de violences.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- L'interroger sur les raisons de ne pas vouloir retirer son pull durant l'examen
- Rechercher si le patient est victime de violences et si oui, quels types
- Evaluer le retentissement psychologique des violences s'il en subit

Vous ne devez pas :

- Poursuivre l'examen clinique
- Rédiger de certificat médical
- Rédiger d'ordonnance
- Faire de signalement judiciaire ou d'information préoccupante

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Interroger sur les raisons de son opposition à l'examen clinique	1 pt	☐
2.	Interroger sur des violences psychologiques	1 pt	☐
3.	Interroger sur des violences sexuelles	1 pt	☐
4.	Interroger sur des violences physiques	1 pt	☐
5.	Interroger sur des idées suicidaires	1 pt	☐
6.	Interroger sur des troubles du sommeil	1 pt	☐
7.	Interroger sur un retentissement scolaire	1 pt	☐
8.	Interroger sur la prise de tabac et de toxiques	1 pt	☐
9.	Interroger sur des comportements d'évitement	1 pt	☐
10.	Interroger sur une variation pondérale récente	1 pt	☐
11.	Rechercher un syndrome anxio-dépressif	1 pt	☐

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TOTAL	**13 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes interne en médecine générale en cabinet.
Vous recevez au cabinet Mathis, 15 ans, amené par ses parents. Il se plaint de douleurs abdominales diffuses, de fièvre et de nausées. Il n'a aucun antécédent. Ses constantes sont dans la norme dont 36,8° de température.
Vous êtes seul.e avec lui pour l'examen. Il refuse de retirer son pull. Vous le trouvez prostré et il évite votre regard. Il accepte cependant une palpation abdominale à travers le pull, qui ne retrouve ni défense ni contracture. Vous suspectez que Mathis est victime de violences.

Plan de la station ECOS :

Le patient est face à l'étudiant.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Vous pouvez me faire un arrêt alors ? J'ai pas pu aller à l'école aujourd'hui et je pourrais pas demain. Je suis trop mal à cause de mon ventre et j'ai envie de vomir depuis ce matin. Je pense que j'ai la gastro. Faut que je reste chez moi.

Identité du patient :

Homme, Mathis, 15 ans, 1m72, 63 kgs

Mode de vie :

Mathis est lycéen dans un établissement privé, en seconde. Il a une petite sœur de 12 ans. Il s'entend bien avec ses parents. Il joue au handball en club et en section sportive au lycée. Il a commencé à fumer depuis son entrée au lycée, notamment du cannabis.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Comportement global :

Mathis porte un pull pour se couvrir complètement jusqu'au poignet alors que la température extérieure est de 27°C. Il a une attitude prostrée, a des réponses concises, évite le regard du médecin. Il est assis de manière avachie sur sa chaise, les bras croisés et refuse de retirer son pull pour l'examen. Il insiste cependant pour avoir un arrêt pour ne pas retourner au lycée.

Mathis est très fermé au début de la consultation aux questions du médecin et répond soit en évitant la réponse soit en essayant de rassurer le médecin en lui disant que tout va bien. Mais lorsque le médecin insiste ou pose la question une deuxième fois, il finit par répondre honnêtement, de manière concise.

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Aucun traitement de fond. Mathis a pris un comprimé de PARACETAMOL deux heures avant la consultation mais il déclare que ça n'a eu aucun effet.

Symptômes positifs :

- Si l'étudiant demande pourquoi le patient ne veut pas retirer son pull → "*Parce que*"
- Si l'étudiant insiste sur la raison pour laquelle le patient ne veut pas retirer son pull → "*Je veux pas que vous regardiez dessous*"
- Si l'étudiant demande la raison pour laquelle le patient ne veut pas qu'il regarde sous son pull → répondez avec un délai de latence de trois secondes "*je veux pas que vous me causiez de problèmes*"
- Si l'étudiant demande quels sont les problèmes que peut avoir le patient → "*je veux pas que vous parliez à mes parents de ce qu'il y a sous mon pull*"
- Si l'étudiant demande la raison pour laquelle le patient ne veut pas que vous en parliez à ses parents → "*ils vont s'inquiéter et ils vont en parler au lycée*"
- Si l'étudiant demande si le patient se scarifie → "*non, je fais pas ça*"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

- Si l'étudiant demande si le patient subi des violences à l'école → répondez avec un délai de latence de trois secondes "*j'ai eu des ennuis avec quelqu'un mais ça va*"

- Si l'étudiant insiste sur les problèmes que le patient rencontre à l'école → "*on m'a frappé au lycée hier*"

- Si l'étudiant demande les types de violences physiques que le patient a subi → "*on m'a donné des coups de poing et des coups de pied dans le dos et dans le ventre… mais c'est rien, ça va, c'était pas fort*"

- Si l'étudiant demande si c'est la première fois qu'il subit des violences physiques au lycée → répondez avec un délai de latence de trois secondes "*non*"

- Si l'étudiant demande des précisions sur les autres faits de violences physiques que le patient a subi au lycée → "*c'est déjà arrivé avant que des gens de ma classe me tapent. Parfois c'est des gifles, parfois ils me poussent. Ils m'ont tapé la tête contre un mur une fois*"

- Si l'étudiant demande si le patient a subi des violences psychologiques —> "*ils m'insultent, ils m'envoient des messages humiliants sur les réseaux*"

- Si l'étudiant demande si le patient a subi des violences sexuelles au lycée → "*non non pas ça*"

- Si l'étudiant demande si le patient a des idées suicidaires → "*non je pense pas à ça*"

- Si l'étudiant demande comment se sent le patient → répondez avec un délai de latence de trois secondes "*ça va, je vais bien, vous inquiétez pas*"

- Si l'étudiant insiste sur l'humeur du patient et lui pose des questions sur sa santé mentale → "*c'est compliqué… quand je vais au lycée, j'ai la boule au ventre. J'arrive moins à me motiver pour faire les choses. Les week-end, je reste surtout dans mon lit, j'ai pas envie d'en sortir.*"

- Si l'étudiant pose des questions sur le sommeil du patient → "*je me couche tard, je dors pas beaucoup. Je fais parfois des cauchemars. Et ça m'arrive de me réveiller plusieurs fois dans la nuit*"

- Si l'étudiant demande s'il y a des choses qui ont changé dans son quotidien depuis qu'il subit des violences → "*Je sèche les cours quand je peux. Je discute moins avec mes potes, je sors moins qu'avant. Et le matin, j'angoisse avant d'arriver au lycée, j'ai une boule au ventre*"

- Si l'étudiant demande s'il y a un retentissement sur sa scolarité —> "*j'ai*

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

du mal à me concentrer, je décroche très vite. Mes parents me disputent parce que mes résultats ont baissé ces derniers temps"

- Si l'étudiant demande si le patient consomme des toxiques → "*j'ai commencé à fumer. Et ça m'arrive de fumer un joint de temps en temps. Mais n'en parlez pas à mes parents s'il vous plaît*"

- Si l'étudiant demande si le patient a perdu ou pris du poids récemment → "*non ça n'a pas changé, je continue encore le sport*"

Constantes :

Pression artérielle : 120/70 mmHg
Fréquence cardiaque : 73 bpm
SaO2 : 99 % en air ambiant
Température : 36,8°C

Donnée complémentaire :

Depuis son entrée au lycée, Mathis subit des violences psychologiques et physiques par certains élèves de sa classe. Les faits ont commencé quelques semaines après la rentrée.

Les violences psychologiques : insultes, cris, rabaissement, messages humiliants sur les réseaux sociaux.

Les violences physiques : Mathis a reçu des gifles, des coups de poings, des coups de pieds et parfois des coups avec des objets comme des livres scolaires. Il y a quelques semaines, ces camarades ont tapé sa tête contre un mur, sans qu'il perde connaissance. La veille de la consultation, ses camarades lui ont donné des coups de poings sur le dos, l'ont jeté au sol puis donné des coups de pied sur le thorax.

Les violences sexuelles : aucune.

Retentissement psychologique : quelques semaines après le début des violences psychologiques et physiques, Mathis a commencé à avoir des troubles du sommeil : il a des difficultés à s'endormir, fait des cauchemars et se réveille plusieurs fois dans la nuit. Il est angoissé tous les matins à l'idée d'aller au lycée. Il a commencé à fumer, notamment du cannabis. Mathis est devenu distant avec ses amis et s'isole de plus en plus. Il préfère rester chez lui plutôt que de sortir avec eux. Il a des difficultés à se concentrer en classe. Ses résultats scolaires sont en baisse alors qu'il était bon élève au début de l'année. Il n'a pas d'idée suicidaire et ne se scarifie pas.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Questions de relance :

Si au bout de 5 min, l'étudiant n'a pas interrogé le patient à propos de violences, vous le relancez avec : "*alors vous me faites un arrêt ? Je ne peux vraiment pas retourner à l'école, je veux plus voir personne*".

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Le médecin (candidat) commence la station assis à son bureau, face au patient.
Un stylo et des feuilles de brouillon sont disposés sur la table devant lui.
Le patient est de l'autre côté du bureau, assis sur une chaise, avachi, les bras croisés, face au médecin mais légèrement tourné sur le côté.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur
- Une table
- Deux chaises

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)